

## 问题与解答

### 001. 哌唑嗪是一种新型抗高血压药, 是否也可治疗充血性心衰?

临床应用证实哌唑嗪(prazosin)能舒张全身静脉和外周动脉血管, 从而增加充血性心衰或肺瘀血病人的心输出量。它对全身动脉、静脉系统的作用有似硝普钠样作用。哌唑嗪和硝普钠均能增加心输出量并降低全身血管阻力, 作用可达6小时, 是长期有效的扩血管药。口服哌唑嗪却是对临床上慢性充血性心衰有治疗作用, 其作用机制尚待进一步研究。(顾性初)

### 002. 噻吗心安是新的肾上腺素能 $\beta$ 阻断剂, 对青光眼的疗效究竟如何?

Zimmerman和Kaufman(1977)用0.5%或1.5%噻吗心安(Timolol)溶液治疗30名青光眼病人, 在用药后7小时左右眼压均有明显降低, 使眼压下降50%, 不影响视觉和瞳孔正常反应。Sonntag等(1978)用本品给19名开角型青光眼患者治疗发现0.5%溶液可有最大的降低眼压作用可达24小时, 未发现全身或局部的副作用。所以, 噻吗心安对开角型青光眼病人可通过房水抑制而降低眼压, 是一种安全有效的新型眼科用药。(顾性初)

### 003. 某育龄妇女患有风湿性关节炎须长期服用保泰松, 该药与口服避孕药之间有无药物相互作用?

动物实验提示保泰松是经肝脏微粒体酶诱导而加速口服避孕药甾体类药物的生物转化, 从而降低口服避孕药效果。不少文献指出, 保泰松可加速口服避孕药在人和动物体内的代谢, 降低避孕药效果。这种相互作用在计划生育门诊病例中值得注意。(顾性初)

### 004. 多巴酚丁胺在心脏方面是否与多巴胺有类似的药理作用?

多巴酚丁胺(dobutamine)与多巴胺都属于儿茶酚胺, 前者的作用部位主要在心脏, 对

外周血管的作用较小。实验表明, 多巴酚丁胺具有正性肌力作用但不增加心率, 也不致诱发心律失常, 因此它治疗伴有心衰和冠状动脉疾病的低心输出量综合症病人可优于多巴胺, 尽管两药均有产生心脏缺血的潜在危险。Ueda等(1977)提示, 多巴酚丁胺对小猎犬右室的正性肌力作用较多巴胺为强。在左侧冠状动脉结扎产生实验性心肌缺血的模型中, 多巴酚丁胺致心律失常作用比其他儿茶酚胺(包括多巴胺)药为少。Loeb等(1977)实验结果表明, 多巴酚丁胺可通过左室充盈压降低而改善心脏效率, 而多巴胺可能因收缩血管反可增加左室充盈压。此外, 多巴酚丁胺还能降低左室舒张末期压而不增加动脉压(这些作用多巴胺所不具备), 故可产生更好的血液动力学作用。因此, 多巴酚丁胺对严重心衰或慢性低心输出量心衰患者是有特殊临床效益。(顾性初)

### 005. 阿司匹林和维生素C联合使用时, 有否相互作用?

维生素C在酶促羟化反应中是作为辅助因子而发挥作用, 所以在感冒、风湿性关节炎、感染性疾病或机体应激情况下, 人体对该药需要量往往增加。人体必需的维生素C贮存于白细胞和血小板中; 服用维生素C 500mg 负荷剂量, 增加阿司匹林剂量能使血浆中维生素C浓度升高而白细胞中的浓度则下降, 说明阿司匹林可减少白细胞对维生素C的吸收。如给予600mg的阿司匹林, 则能完全抑制白细胞对维生素C的吸收。因此医师给风湿性关节炎病人服用大量阿司匹林时, 应同时补充维生素C。(顾性初)

### 006. 抗高血压药物硝苯吡啶有很好的抗心绞痛作用, 请提供有关方面资料

美国食品与药物管理局已把硝苯吡啶作  
(下接第36页)